의료통합을 위한 통합교육 구축 전략 및 추진 계획서 (2026~2035)

Oct 26, 2026 · @김재효

요약

이 계획서는 2035년까지 **면허 통합보다 교육·기능 통합을 먼저** 이루는 10년 계획입니다. 한의과대학 교육을 근거 기반·실습 중심으로 바꾸고 의과대학과 공통 역량을 공유해, 의사와 한의사가 노인·만성질환·지역 돌봄에서 협진하는 체계를 만드는 것이 목표입니다. 면허 통합 여부는 이 계획의 전제가 아니라, 3단계 성과 평가 뒤 사회적 합의로 정할 선택지로 둡니다.

왜 지금인가

- **교육 재정**: 한의대 학생 1인당 교육비는 연 1,020만 원으로 의대(4,070만 원)의 25%입니다. 실습 비중을 두 배로 늘리는 개편을 뒷받침할 돈이 없습니다.
- **인력 수급**: 기본 시나리오에서 2030년 의사는 약 2,400명 부족, 한의사는 약 2,700명(11.6%) 과잉입니다. 한의사 인력의 역할을 다시 설계해야 합니다.
- **의료비 구조**: 한의 의료비는 총의료비의 4.64%지만 한약 지출의 약 96%가 비급여입니다. 교육 내용과 급여 체계가 따로 움직입니다.

4대 전략: ① 교육과정 통합 ② 임상 실습·협진 인프라 ③ 재정·인력 수급 조정 ④ 제도·급여·거버넌스 정합.

추진 단계: 1단계 기반 구축(2026~2028) → 2단계 확산(2029~2031) → 3단계 정착·평가(2032~2035). 단계 사이에 관문을 두어, 진입 조건을 채우지 못하면 다음 단계로 넘어가지 않습니다.

핵심 재원: 한의대 교육재정 보전에 국고 연 약 250억 원(5년 1,250억 원)이 필요합니다. 1인당 교육비를 의대의 39%(1,580만 원)까지 올리는 규모입니다.

추진 배경과 현황 진단

재정·수급·급여 세 축이 동시에 어긋나 있어, 교육과정만 바꾸는 개편은 성과로 이어지기 어렵습니다. 지금까지의 분석 결과를 다섯 영역으로 묶으면 다음과 같습니다.

진단 영역	핵심 근거	통합교육에 주는 함의
의료비 구조	한의 의료비 4.64%(2023, 4.73조/101.9조 원). 건보 급여 비중 4.11%(2023) → 4.56%(2024). 건보 한방 약품비 441억 원(0.16%), 한약 지출의 약 96%는 비급여	가르치는 치료(첩약·한약)가 급여 밖에 있어, 교육 개편과 급여 편입 근거 생산을 묶어야 함

진단 영역	핵심 근거	통합교육에 주는 함의
인력 수급	2030년 의사 약 2,400명 부족, 한의사 약 2,700명(11.6%) 과잉(기본 시나리오). 의대 정원 3,058명 → 3,548명(2027), 한의대 정원 750명	한의사를 방문진료·노인 돌봄 등 부족 영역에 투입할 역량 교육이 필요하고, 정원은 양 직역 공동 추계로 조정해야 함
교육 재정	연 교육재정 의대 약 8,080억 원, 한의대 약 460억 원(18배). 1인당 4,070만 원 대 1,020만 원. 한의대 12개교 중 11개가 사립	실습 45% 개편을 등록금으로는 감당할 수 없어 국고 보전이 전제
국제 비교	일본: 단일 면허, 의사가 한방 엑스제 148처방을 급여 처방(의료용 의약품의 2.25%), 총의료비 비중은 0.7% 이하. 중국: 병원 중심 중서의결합, 약 7.9%. 대만: 이원 면허 + 중의 총액 4.0% 사전 보장, 과립 한약 급여	면허 통합(일본형)은 전통의학 비중 축소를 동반했고, 한국과 가장 비슷한 대만형은 급여 정합이 핵심. 기능 통합 + 급여 정합이 현실적
교육과정 초안	원광대 통합의료 6년제 초안: 248.5 → 218학점, 이론:실습 78:22 → 55:45, 본4 서브인턴십 40주(1,600시간), 노년증후군 6대 CPG 모듈	방향은 타당하나 재택 실습 시간(80 대 160시간), 국고 규모(630억 대 1,250억 원), 기대효과 수치, 초음파 등 업무범위의 법적 근거를 보완해야 함

이 진단에서 나온 10가지 전제 조건(통합 목적 명확화부터 의과 교육 상호 개편까지)을 아래 4대 전략의 세부 과제로 바꾸었습니다.

비전, 목표, 추진 원칙

비전: 근거에 기반해 두 의학의 강점을 함께 쓰는 의료인을 길러, 고령사회의 일차·지역 돌봄 공백을 메운다.

2035년 목표

1. **교육**: 통합 교육과정을 한의학교육 평가인증 기준에 반영하고, 시범 대학 평가를 통과하면 전체 한의대로 확산한다.
2. **진료**: 의·한 협진과 지역 방문진료에서 한의사의 역할을 제도로 정한다.
3. **제도**: 교육받은 진료가 급여 범위·법적 업무범위와 일치하게 한다.

추진 원칙

1. **기능 중심·단계적 통합**: 면허 통합을 먼저 정하지 않고 공통 역량과 협진 기능부터 맞춘다.
2. **근거 우선**: 교육과 급여에 넣는 한의 치료는 임상진료지침(CPG) 근거 등급으로 범위를 정한다.
3. **상호성**: 한의대만 바꾸지 않는다. 의대에도 통합의학·한의학 이해 교과와 협진 실습을 둔다.
4. **공정한 전환**: 재학생과 기존 면허자에게는 불이익 없는 경과 조치를 적용한다.
5. **관문 기반 추진**: 단계 진입 조건을 미리 공표하고, 독립 평가로 통과 여부를 판단한다.
6. **동등한 참여**: 의사·한의사 단체, 두 교육평가원, 대학, 환자·시민이 같은 테이블에서 결정한다.

통합의 최종 형태는 여전히 쟁점입니다. 의사 단체 일부는 한의학 교육의 의대 흡수나 일원화 반대를, 한의사 단체는 독립 면허 유지와 현대 진단기기 사용 확대를 주장해 왔습니다. 이 계획은 어느 쪽 결론도 전제하지 않고, 양쪽이 평가할 수 있는 성과 자료를 만드는 데 초점을 둡니다.

4대 전략과 세부 과제

18개 세부 과제는 모두 앞서 정리한 10가지 전제 조건 중 하나 이상을 충족하도록 짠습니다. '전제' 열의 번호는 ① 통합 목적·방식 ② 근거 기반 범위 ③ 교육-급여 정합 ④ 공동 수급추계·정원 ⑤ 기존 면허자·재학생 전환 ⑥ 교육재정 형평 ⑦ 협진·실습 인프라 ⑧ 거버넌스·성과평가 ⑨ 업무범위 법적 정비 ⑩ 의과 상호개편입니다.

전략 1. 교육과정 통합

의·한이 공유하는 성과 기반 역량을 먼저 정하고, 원광대 초안을 그 위에서 시범 적용합니다.

과제	내용	전제	주관	시기
1-1 공통 역량 프레임워크	기초의학·임상추론·환자안전·협진 역량을 의·한 공통 목표로 제정	①②	의학·한의학교육평가원, 학장협의회	2026~2027
1-2 원광대 초안 보완·시범	218학점·실습 45% 유지, 재택 실습 160시간으로 통일, 6대 CPG 모듈에 근거 등급 표기	②	원광대	2026 확정, 2027 신입생부터
1-3 의대 상호 교과	통합의학·한의학 이해 필수 교과, 협진 선택 실습 개설	⑩	협력 의대	2028 시범
1-4 공동 강좌·학점 상호인정	기초의학 공동 강좌, 교수 겸임·교류	①⑥	대학, 교육부	2029~
1-5 평가·국가시험 연계	KAS2022 개정 (P2.1·P2.4·P2.5.4·P5.1.2), 한의사 국시의 임상수행 평가 확대	③⑧	한의학교육평가원, 국시원	2027~2031

전략 2. 임상 실습·협진 인프라

실습 비중 45%와 본4 서브인턴십 40주는 실습지와 지도 인력이 없으면 운영할 수 없습니다.

과제	내용	전제	주관	시기
2-1 협진 수련 거점 지정	한방병원·의과 병원 협진 실습기관 지정 기준과 지원	⑦	보건복지부, 대학병원	2027~2029
2-2 서브인턴십 운영 기준	실습지 확보, 학생 대비 지도인력 기준, 실습 안전·책임 규정	⑦	대학, 평가원	2028~2030
2-3 지역사회 방문 진료 실습	지자체 통합돌봄과 연계한 노년증후군 재택 실습	③⑦	대학, 지자체	2028~
2-4 임상교원 확보·역량 개발	임상교원 충원, 의과 교수 겸임, 교수법 연수	⑥⑦	대학	2027~2031

전략 3. 재정·인력 수급 조정

한의대의 낮은 교육비와 한의사 과잉 추계를 함께 다룹니다.

과제	내용	전제	주관	시기
3-1 교육재정 보전	한의대 1인당 교육비 +560만 원, 국고 연 약 250억 원	⑥	교육부, 기획재정부	2027~2031
3-2 의·한 공동 수급추계	한의사를 의사와 같은 모형·주기로 추계하고 결과 공개	④	보건복지부 수급추계위	2026~, 매년
3-3 한의대 정원 조정 검토	2030년 과잉 추계 약 2,700명(11.6%)을 반영해 감축 또는 통합 트랙 전환을 결정	④	보건복지부, 교육부	2028 결정
3-4 기존 면허자 전환교육	협진·노년의학·방문진료 인증 보수교육	⑤	한의사협회, 대학	2028~
3-5 재학생 경과 조치	기존 교육과정 이수자의 국시 응시·면허 범위 보장	⑤	교육부, 국시원	2027~2032

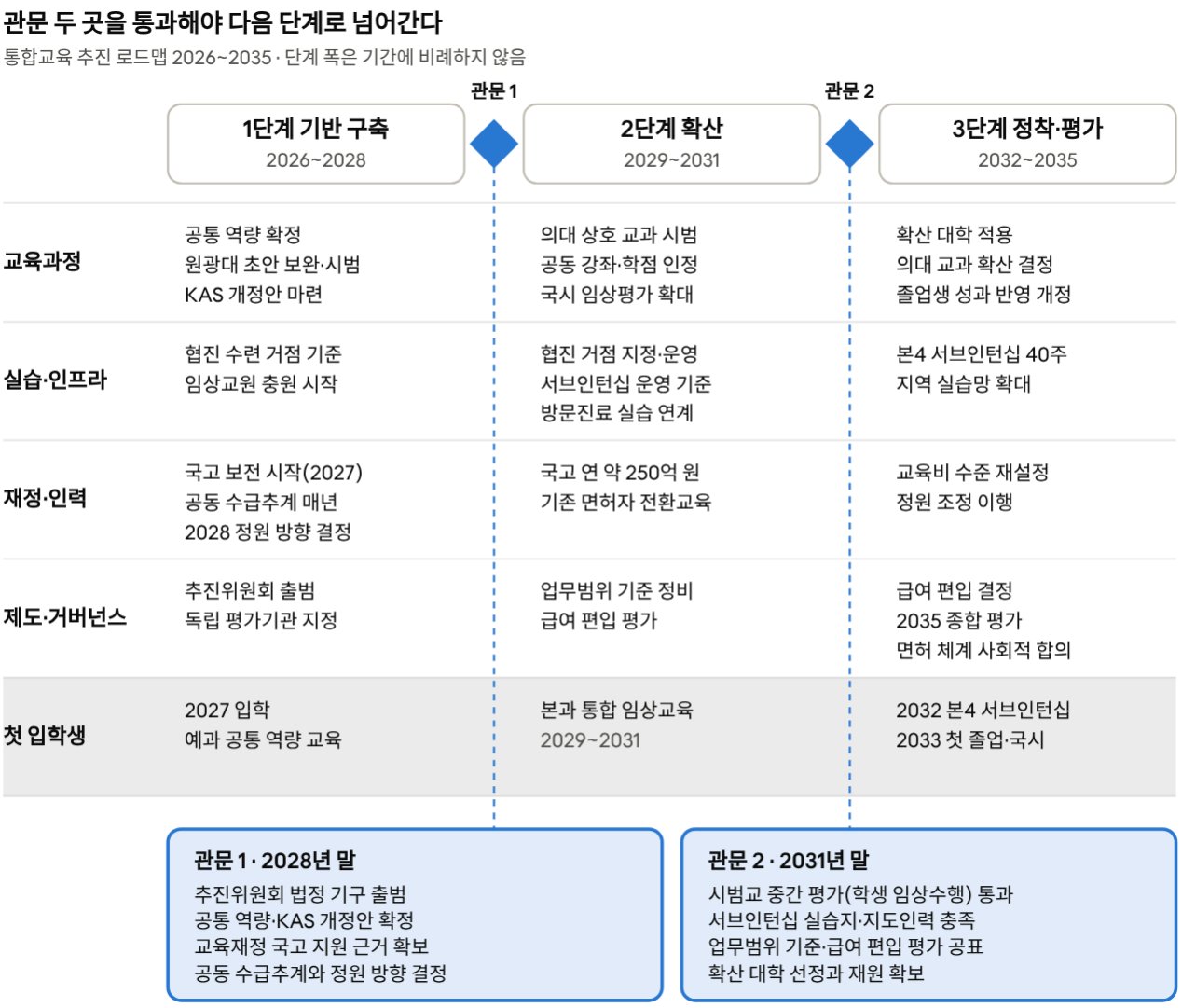
전략 4. 제도·급여·거버넌스 정합

교육에서 가르친 것을 진료 현장에서 할 수 있게 만드는 전략입니다.

과제	내용	전제	주관	시기
4-1 범정부 추진 위원회	복지부·교육부·기재부와 양 직역, 평가원, 시민이 참여하는 법정 기구	⑧	보건복지부	2026~2027
4-2 업무범위 법적 정비	초음파 등 진단기기 사용 범위를 교육 이수·인증과 연계한 기준으로 정리	⑨	보건복지부, 국회	2027~2030
4-3 급여 정합	6대 CPG 질환의 첩약·한약제제 급여 편입 평가, 첩약 시범사업 2단계 결과 연계	②③	보건복지부, 심평원	2028~2032
4-4 독립 성과평가	졸업생 코호트 추적, 협진 성과·비용 평가, 단계별 관문 심사	⑧	독립 평가기관	2027~2035

단계별 추진 로드맵

2028년 말과 2031년 말 두 관문에서 진입 조건을 심사하고, 충족하지 못하면 시범 범위를 유지한 채 다음 단계로 넘어가지 않습니다.



통합교육 추진 로드맵 · 3단계, 관문 2곳, 4대 전략 + 첫 입학생

2027년 첫 입학생은 2032년 본4 서브인턴십을 거쳐 2033년에 졸업하므로, 졸업생 성과는 3단계 후반에야 확인됩니다. 관문 2의 확산 결정은 졸업생이 아니라 재학생의 중간 평가에 기대야 하는 이유입니다.

소요 예산과 재원

확정할 수 있는 항목은 한의대 교육재정 보전 하나이며, 2027~2031년 국고 약 1,250억 원(연 약 250억 원)입니다. 나머지는 단가·대상이 정해지지 않아 1단계에서 산정해야 합니다.

항목	산정 근거	규모
교육재정 형평 보전	한의대 재학생 약 4,500명(정원 750명 × 6년) × 1인당 +560만 원	연 약 250억 원, 5년 약 1,250억 원
협진 수련 거점·실습지	거점 수와 기관당 지원 단가 미정	1단계 산정

항목	산정 근거	규모
기존 면허자 전환교육	수요조사 후 대상 인원·교육 단가 결정	1단계 산정
의대 상호 교과	협력 의대의 기존 교육 예산 안에서 운영	소규모
독립 성과평가	코호트 추적·비용 평가 연구	1단계 산정

- **초안 수치 정리**: 초안에는 국고 630억 원과 1,250억 원이 함께 나옵니다. 재학생 수와 1인당 격차로 다시 계산하면 1,250억 원이 맞아, 이 계획은 1,250억 원을 기준으로 쓰는 것을 제안합니다.
- **격차 해소 정도**: 보전 후에도 한의대 1인당 교육비는 의대의 39%입니다. 실습 45% 운영에 충분한지는 시범교 실제 비용으로 관문 1에서 다시 판단합니다.
- **재원 구성**: 국고(교육부 고등교육 재정, 보건복지부 인력 양성 사업)가 중심입니다. 지역 방문진료 실습은 지자체 통합돌봄 예산과, 급여 편입분은 건강보험 재정 영향을 따로 추계합니다.
- **등록금 전가 금지**: 12개 한의대 중 11개가 사립이라, 개편 비용을 등록금으로 넘기면 학생 부담과 지역 격차가 커집니다.

성과 지표와 목표치

가장 중요한 성과는 2033년 처음 배출되는 통합과정 졸업생(2027년 입학)의 임상 역량을 기존 과정 졸업생과 비교한 결과입니다. 아래 목표치는 이 계획의 제안(안)이며, 관문 심사 때 다시 정합니다.

지표	기준값	2031 목표	2035 목표
한의대 1인당 교육비	1,020만 원(의대의 25%)	1,580만 원(39%)	시범교 실제 비용으로 재설정
이론:실습 비율(시범교)	78:22	55:45	55:45 유지
총 이수 학점(시범교)	248.5학점	218학점	218학점
통합 교육과정 적용 한의대	없음	원광대 시범 + 확산 대학 선정	관문 2 통과 시 12개교
통합의학 필수 교과 개설 의대	미파악(1단계 조사)	협력 의대 시범	확산 여부 결정
통합과정 졸업생 임상 수행 평가	—	—	기존 과정 대비 동등 이상
방문진료 참여 한의사·건수	미파악	지자체 연계 실습 운영	초안 목표(연 750명·150만 건) 검증 후 확정

지표	기준값	2031 목표	2035 목표
의·한 공동 수급추계 공개	없음	매년	매년

건보 급여 중 한의 비중(2024년 4.56%)은 목표가 아니라 모니터링 지표로 둡니다. 2024년 상승분에는 상급종합병원 진료비가 줄어든 분모 효과가 섞여 있기 때문입니다.

추진 체계와 이해관계자 협력

범정부 추진위원회가 관문 통과를 의결하고, 네 분과가 전략별 과제를 맡습니다. 성과평가 분과는 독립 기관이 맡아, 추진 주체가 자기 성과를 평가하지 않게 합니다.

주체	역할
의료·교육 통합 추진위원회	관문 기준 공표·통과 의결, 부처 간 조정. 복지부·교육부·기재부, 양 직역, 환자·시민 동수 참여
교육과정 분과	공통 역량, 시범 교육과정, 평가인증 기준 개정(전략 1)
실습·인프라 분과	협진 거점, 서브인턴십, 지역 실습(전략 2)
인력·재정 분과	교육재정 보전, 공동 수급추계, 정원, 전환교육(전략 3)
제도·급여 분과	업무범위, 급여 편입 평가(전략 4)
독립 성과평가기관	코호트 추적, 관문 심사 자료 작성·공개
대한의사협회·대한한의사협회	분과별 위원 추천, 관문 기준 협의, 보수교육 운영
한국의학교육평가원·한국한의학교육평가원	평가인증 기준 개정과 상호 연계
한국보건의료인국가시험원	국시 문항·실기시험 개편
대학(의대·한의대)·병원·지자체	시범 운영, 실습지 제공, 통합돌봄 연계

협력을 얻는 핵심 장치는 세 가지입니다. 관문 기준을 시작 전에 양 직역이 함께 정하고, 평가 자료를 전부 공개하며, 어느 단계에서든 중단·수정할 수 있는 절차를 둡니다.

위험 요인과 대응

가장 큰 위험은 직역 간 합의 실패와 재정 미확보이며, 두 가지 모두 1단계 관문에서 차단하도록 설계했습니다.

위험	가능성	영향	대응
직역 간 갈등로 합의 지연	높음	높음	관문 기준 사전 합의, 중립 의장, 평가 자료 전면 공개
교육재정 미확보	중간	높음	1단계에 법적 지원 근거 마련, 확보 전에는 시범 범위 축소
업무범위를 둘러싼 법적 분쟁	높음	중간	기준 정비 전에는 현행법상 허용 범위에서만 수행 실습, 나머지는 이해·연계 교육
실습지·지도인력 부족	중간	높음	협진 거점 지정, 의과 교수 겸임, 서브인턴십 단계적 확대
근거가 약한 교육 모듈	중간	중간	CPG 근거 등급이 낮은 모듈은 선택 과목으로, 근거 생산 연구와 병행
재학생·기존 면허자 불이익	중간	높음	경과 조치 법제화, 전환교육 인증 제도
기대효과 과대 추정	중간	중간	초안의 절감액(3,200~5,400억 원) 등은 검증 전에 정책 목표로 쓰지 않음
의대 정원 정책 변동	중간	중간	공동 수급추계를 매년 갱신해 한의대 정원 결정과 연동

근거 자료

이 계획서의 수치는 아래 선행 분석과 첨부 자료에서 가져왔습니다. 개별 통계의 원출처는 각 문서의 출처 절에 있습니다.

선행 분석

- `한·중·일·대만 전통의학 vs 서양의학 의료비용 비교 분석`: 한·중·일·대만 의료비 구조, 한국·일본 한방 의약품 규모
- `국내 의과대학 vs 한의과대학 교육 재정 비교`: 의대·한의대 교육재정과 1인당 교육비
- `의사 vs 한의사 인력 수급 시뮬레이션 (2021~2030)`: 2021~2030년 수급 시뮬레이션, 교육과정 개편 초안 검토, 10가지 전제 조건

첨부 자료

- 한의약 전체 vs 양방 전체 의료비용(급여 및 비급여) 비교분석 보고서
- 원광대 통합의료 6년제 한의학교육과정 개편 초안(마스터플랜)

주요 외부 자료

- 2024년 한방 약품비 441억 원·비중 0.16% (팜뉴스, 2026.6.21)
- 2024 급여의약품 청구 현황 (건강보험심사평가원)
- 첩약 건강보험 2단계 시범사업 (한경비즈니스, 2024.4.28)
- 令和6年 薬事工業生産動態統計年報 (일본 후생노동성)
- 116년도 건보 총액 협상 결과 공고 (대만 위생복리부)
- 2024년 위생건강사업발전 통계공보 (중국 국가위생건강위원회)

예산의 재학생 수(약 4,500명)는 정원 × 6년으로 계산한 추정치이며, 휴학·유급을 반영하면 달라질 수 있습니다.